



LAPORAN KEJADIAN

1.	Pembuat Kronologi	Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM.
2.	Kejadian	Ketidaksesuaian Pembayaran Jasa Pembacaan ECG Pasien APS
3.	Unit Kerja yang Terlibat	1. Laboratorium 2. Pendaftaran 3. Kasir
4.	Tanggal Kejadian	Sabtu, 14 Februari 2026
5.	Sumber Informasi	Laporan dr. Vidi, Sp.PD kepada dr. Aji, Sp.PD terkait adanya konsul pembacaan ECG namun biaya jasa tidak ada di rincian penerimaan honor.

I. KRONOLOGI KEJADIAN

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang Terlibat
14/02/2026	18:41 – 19:20	dr. Aji, Sp.PD menghubungi Amanda terkait pembagian jadwal konsulan pembacaan ECG dari Lab untuk pasien APS (Genap: dr. Vidi; Ganjil: dr. Aji). Amanda menyampaikan jadwal baru ke Lab dan meminta rekap konsulan pembacaan ECG ke Lab. dr. Aji meminta Amanda untuk menghubungi dr. Vidi terkait rincian pembayaran jasa pembacaan ECG.	dr. Aji, Amanda, Petugas Lab
	19:26 – 19:49	Amanda <i>crosschecking</i> tarif pembacaan ECG ke kasir, tarif pembacaan ECG Rp.15.000 (Rp.10.000 jasa dokter dan Rp.5.000 administrasi rumah sakit).	Amanda, Petugas Kasir, Petugas Lab
	20:00 – 21:03	Dr. Vidi lapor melalui dr. Aji ke Amanda terkait honor pembacaan tidak ada di rincian honor sejak November. Amanda melakukan konfirmasi ke Bu Noven (Keuangan PT) terkait dugaan JM masuk ke dr. Brilliant karena pada billing pembayaran tertera nama dr. Brilliant.	dr. Vidi, dr. Aji, Amanda, Bu Noven
15/02/2026	08:27 – 10:34	Amanda menemukan adanya billing pembacaan ECG kosong tanpa nama dokter. Identifikasi awal adalah Lab tidak menginfokan ke kasir terkait siapa dokter yang melakukan pembacaan.	Amanda, Unit Lab, Unit Kasir
	11:20 – 15:31	Amanda mendapati ada pasien yang sudah dilakukan pembacaan oleh dokter namun tidak ada billing pembacaan yang terinput. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pembayaran yang masuk ke RS.	Amanda, Unit Kasir, Unit Lab
	21:03	Amanda mengonfirmasi ke Bu Noven bahwa hak dokter yang terlewat akan dirapel pada honor Februari (terbayarkan Maret)	Amanda, Bu Noven
16/02/2026	08:48 – 09:17	Amanda menghadap Bu Noven terkait hilangnya potensi pendapatan RS. Bu Noven menginstruksikan pembuatan kronologi tertulis sebagai dasar kebijakan pembayaran selanjutnya.	Amanda, Bu Noven, Unit Lab, Unit Kasir, Unit Pendaftaran



II. HASIL TELUSUR

1. Ditemukan bahwa unit Laboratorium tetap melakukan prosedur konsul pembacaan ECG kepada dokter spesialis meskipun pada sistem pendaftaran pasien tersebut hanya terinput "Pemeriksaan ECG" tanpa komponen "Pembacaan ECG". Hal ini menyebabkan tindakan medis dilakukan tanpa adanya dasar tagihan (*billing*) yang terbit.
 2. Pada kasus di mana pasien telah didaftarkan dengan komponen "Pembacaan ECG", ditemukan bahwa nama dokter pembaca yang muncul secara otomatis di sistem adalah dr. Brilliant, Sp.PK. Petugas Kasir tidak melakukan perubahan nama ke dokter yang sebenarnya melakukan pembacaan saat finalisasi billing.
 3. Unit Pendaftaran tidak secara otomatis memasukkan biaya pemeriksaan (Rp65.000) dan biaya pembacaan (Rp15.000) sebagai satu kesatuan paket untuk pasien ECG APS, sehingga memperbesar peluang terlewatnya input jasa pembacaan.
 4. Unit Laboratorium melakukan pencatatan mandiri terkait dokter yang melakukan pembacaan, namun data tersebut tidak pernah disampaikan ke Unit Kasir sejak September 2025.
 5. Akibat dari ketidaksinkronan antara tindakan di lapangan dan input sistem ini, rumah sakit kehilangan pendapatan resmi, sementara rumah sakit tetap memiliki kewajiban membayarkan jasa medis kepada dokter karena tindakan pembacaan telah dilakukan.

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit (Pendaftaran, Laboratorium, dan Kasir) terkait alur pelaporan dokter pembacaan ECG untuk pasien APS.
 2. Tidak adanya sistem integrasi otomatis di bagian Pendaftaran yang menggabungkan tarif pemeriksaan dan pembacaan ECG untuk pasien APS dalam satu billing.
 3. Ketergantungan operasional yang tinggi pada penanggung jawab unit sebelumnya (Rotasi Bu Ika dan Lab ke Humas & Marketing) sejak bulan September 2025, menyebabkan staf kehilangan inisiatif dan kemandirian dalam melakukan *crosscheck* rutin terhadap *billing*.
 4. Minimnya inisiatif staf untuk memahami tanggung jawab adminisyratif pasca-pemeriksaan, sehingga fungsi control terhadap jasa dokter terhenti sepenuhnya.

IV. KERUGIAN YANG TIMBUL

1. Terdapat total tagihan jasa medis sebesar Rp.390.000 yang harus dibayarkan secara rapel kepada dr. Aji, Sp.PD., dr. Vidi, Sp.PD., dan dr. Cik, Sp.J sebagai bentuk hak pemenuhan professional dokter.
 2. Rumah sakit mengalami kerugian pendapatan sebesar Rp.135.000 akibat tindakan pembacaan yang dilakukan namun tidak tertagih ke pasien (tidak ada dasar *billing*).
 3. Tertundanya pemenuhan hak jasa medis para dokter spesialis sejak periode September 2025 hingga Februari 2025.

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

- Eksternal**

 1. Meyampaikan penjelasan kepada dr. Aji, Sp.PD. dan dr. Vidi, Sp.PD., mengenai kendala sistemik yang terjadi
 2. Memastikan pemenuhan hak jasa medis mereka secara rapel pada honor Februari 2026 yang akan diterimakan pada Maret 2026.
- Internal**

 1. Melakukan telusur data menyeluruh di 3 Unit (Pendaftaran, Laboratorium, dan Kasir) untuk mengidentifikasi seluruh transaksi yang tidak tertagih sejak September 2025.
 2. Kerugian pendapatan RS sebesar Rp135.000 akan ditanggung bersama oleh 14 orang staf dari 3 unit terlibat (Pendaftaran, Laboratorium, dan Kasir). Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui pemotongan gaji bulan Februari 2026 (terbayar di bulan Maret 2026).



3. Menyusun dan mensosialisasikan SPO baru mengenai alur konsul EKG APS dan kewajiban pelaporan rekapitulasi harian ke unit Kasir. Untuk Pasien APS: Pendaftaran wajib memasukkan tarif pemeriksaan dan pembacaan sebagai satu paket. Unit Lab wajib menginfokan identitas dokter pembaca ke Unit Kasir. Untuk Pasien Ranap/Rajal/Konsul: Setiap tindakan pembacaan (baik diminta oleh spesialis lain maupun oleh Sp.PD/Sp.JP sendiri) wajib menyertakan komponen "Pembacaan ECG" dan mencantumkan nama dokter pembacanya pada sistem billing.
4. Mengaktifkan rapat bulanan agar unit memantau progress dan membangun kemandirian staf dalam menjalankan fungsi kontrol administratif tanpa bergantung pada individu tertentu.

VI. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	Tertanda
Kepala Unit Pendaftaran dan Rekam Medis	Telah ditindak lanjuti dan didiskusikan bersama unit terkait mengenai alur pelayanan ECG dan penyesuaian terhadap program di E-Prima.	 Anggun Putri Wahyu Hapsari, A.Md.RMIK
Kepala Unit Kasir	Konfirmasi terkait tarif pembacaan dan tindakan ECG ke pasien. Dan verifikasi kesesuaian inputan nama dokter yang melakukan pembacaan	 Yanik Heri Sulistianingsih
Kepala Unit Laboratorium	1. Memastikan SOP terkait penerimaan pasien dgn menunjukkan bukti pelunasan berjalan dengan sesuai. 2. Saat membantu mengingatkan Unit PDF terkait input Pembacaan ECG ada bukti tertulis (by WA) selain juga dengan aiphone untuk mempercepat informasi tersampaikan 3. Melaksanakan rapat rutin/ evaluasi kerja unit.	 Ika Aries Widyasari, A.Md.AK
Kabid Pelayanan Medis	Memastikan: 1. KIE saat di TPP pemeriksaan ECG yang diminta pasien beserta jasa pembacaan ECG, diluar tarif pemeriksaannya 2. Input Jenis Pemeriksaan dan jasa Pembacaan langsung oleh TPP 3. Pasien melakukan Pembayaran ke kasir dengan tetap konfirmasi apa saja item yang dibayarkan Kasir melakukan konfirmasi kepada Laboratorium 4. Laboratorium identifikasi pasien untuk pemeriksaan yang akan dilakukan	 dr. Dyan Santi Palupi
SDM	1. Tindak lanjut kekurangan fee dokter 2. Telusur SPO pelayanan ECG dengan system yang berjalan 3. Pastikan nama dokter terinput dalam system di setiap layanan	



Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	Tertanda
	4. Kerugian perusahaan ditanggung unit terkait	 Saniza Indra Putri Glassya, S.Psi

Probolinggo,16 Januari 2026

Menyetujui,
Direktur RS Dharma Husada

Pembuat Kronologi,



(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.)



(Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM.)

Catatan Direktur: _____